評価の説明

※以下の評価基準は公的なものではありません。一般的な基準をもとに作成しています。

1. 指標別：評価点（スコアリング）構成表

各指標（0〜4点）の算出基準と、その数値が示す現場の状態です。

点数	病床利用率（安定性）	病床稼働率（現場負荷）	病床回転率（効率性:月間）	指標の解釈（ニュアンス）
4点	90%以上	95%以上	2.5回以上	卓越： 地域の需要を独占し、極限までリソースを活用。
3点	85%以上	90%以上	2.0回以上	優良： 理想的な運用。収益と質のバランスが最適。
2点	75%以上	80%以上	1.5回以上	標準： 平均的。大きな問題はないが、改善の余地あり。
1点	60%以上	70%以上	1.0回以上	低迷： 活気が不足。空床や滞留の兆候が見られる。
0点	60%未満	70%未満	1.0回未満	

2. 合計点・ランクと【AI診断】対応表

合計点から算出される総合ランクと、AIがその「点数の組み合わせ」から読み取る診断内容です。

ランク	合計点	AI診断ニュアンスの代表例	診断の視点（AIロジック）
S	11〜12	【超高効率】地域の中核として完璧な稼働。	全指標がトップ。現状維持が最大の課題。
A	8〜10	【急性期特化】回転は速いが空床が目立つ。	病床回転率の点数が高い ＝ 腕は良いが、集患が課題。
		【地域密着型】安定しているが患者が滞留気味。	病床利用率の点数が高い ＝ 信頼はあるが、退院支援が課題。
B	5〜7	【機能過剰】運用能力は高いが需要不足。	病床回転率の点数は高いが病床利用率が低い ＝ 紹介元営業を。
		【停滞傾向】満床に近いが入れ替わりがない。	病床利用率の点数は高いが病床回転率が低い ＝ 長期入院の是正を。
C	2〜4	【固定化リスク】病床は埋まっているが機能不全。	病床回転率がほぼゼロ。療養への機能転換を検討。
		【低活動】集患と運用の両面に課題あり。	全指標が平均以下。体制の抜本的見直し。
D	0〜1	【構造改革対象】存続の危機。早期の判断を。	経営維持が困難なレベル。事業再編の対象。

3. 分析を読み解くための「AI視点」ガイド

AIが診断を下す際に重視している「乖離（ギャップ）」の読み解き方です。

①病床回転率の点数 ＞ 病床利用率の点数（腕はあるが患者がいない）
②技術や効率は高いが、紹介患者の確保（営業活動）が不足している「宝の持ち腐れ」状態。
③病床利用率の点数 ＞ 病床回転率の点数（患者はいるが腕が遅い）
④地域に根ざしているが、退院調整が遅れてベッドが「詰まっている」状態。収益の伸び代はここにある。
⑤病床稼働率の点数 ＞ 病床利用率の点数（忙しいだけで実入りが少ない）
②入院・退院の事務手続きやベッドメイクの負荷が高い割に、夜間の実入院患者数が伸びていない「非効率」な状態。

4. 各指標の計算式と評価

病床利用率	計算式： 一日平均入院患者数／病床数（許可病床または稼働病床×100 一般的に「分母：動かせるベッドの数」に対して「分子：実際に使われたベッドの数（延べ患者数）」が どれくらいかを算出するものです。 90%以上【満員御礼】 地域からの需要が極めて高く、常に満床に近い状態。収益性は最大化されているが、 緊急入院の受け入れ余力が少ない。 85%以上【理想的運用】 安定した経営。適度な空床があり、効率と安全性のバランスが最適。 75%以上【標準的】 特筆すべき問題はないが、空床コストが発生している。集患対策の余地あり。 60%以上【低迷】 稼働にムラがある。病床の役割（診療科など）が地域のニーズとズレ始めている可能性。 60%未満【閑散】 赤字リスクが高い。病床削減や機能転換（一般から療養へなど）の検討が必要。
病床稼働率	計算式：（一日平均入院患者数 + 一日平均退院数）／病床数×100 「退院当日の空床（入れ替えによる稼働）」を評価に含めた実質的な稼働率を算出しています。 この計算式は、現場の「忙しさ」や「ベッドの回転」をより正確に反映させるためのものです。 95%以上【フル稼働】 退院と入院の隙間がほとんどない。現場のオペレーション能力が極めて高く、 1床あたりの収益効率が最大化されている。 90%以上【高効率運用】 ベッドメイクと次の受け入れがスムーズに連携できている。急性期病院として理想的な回転速度。 80%以上【標準的運用】 現場に無理のないペース。急な入院にもある程度対応可能な余裕がある。 70%以上【低活動】 入院準備に時間をかけすぎているか、そもそも次の患者が待機していない。効率改善の余地が大きい。 70%未満【停滞】 ベッドが動いていない。運用の仕組み（クリニカルパス等）の見直しが必要。
病床回転率（回/年）	計算式：年間新入院患者数／病床数 ※計算式（近似式）：（一日平均入院患者数｝×365）／平均在院日数÷病床数 今回は正確な「新入院患者数」のデータが直接得られないため、近似式で算出しています。 さらに1/12して月間回転数として算出 2.5回以上／月（30.0 以上／年）【超高速循環】 1ベッドに月2.5人以上が入院。急性期機能が極めて高く、次々と 新しい患者を受け入れている。 2.0回以上／月（24.0 ～ 29.9／年）【高効率運用】 適切なサイクルで患者が入れ替わっている。経営効率が非常に良い理想的な状態 1.5回以上／月（18.0 ～ 23.9／年）【標準的】 一般的な一般病棟のペース。無理のない範囲での回転。 1.0回以上／月（12.0 ～ 17.9／年）【長期化傾向】 患者が滞留気味。リハビリ転院や在宅復帰の調整が遅れている可能性。 1.0回未満／月（12.0 未満／年）【停滞・固定化】 患者がほとんど入れ替わっていない。慢性期（療養）に近い運用実態。
平均在院日数と 病床利用率の関係	計算式：延べ在院患者数／（新入院患者数＋退院患者数））÷2 質の向上: 短いほど効率的でが、再入院率など考慮する必要がある。 地域連携: 在院日数の短縮は、地域の医療機関や介護施設との連携（退院支援）が必要です。 平均在院日数を過度に短縮しても次の新入院患者を獲得できなければ、病床利用率低下の要因になります。 新入院患者が確保できないため、安易に在院日数を延ばして空床を埋める方策は医療の質や診療報酬（DPC制度等）の 観点からは、望ましいものではありません。